

Keuhkot:

- B-viivat?
- Pleuraneste?

PLAX:

- Nopea silmämääräinen arvio
 - o Ejektiofraktio?
 - o Paikalliset hypokineettiset alueet?
 - o Perikardiumeffuusiota?
 - o Läpät (kalkkisuus, liike, vegetaatiot, dopplerilla vuodot/stenoottismaiset virtaukset); RV-inflow-ikkunasta trikuspidaaliläppä ja sen gradientti
 - Aorttavuodosta voi ottaa jo tässä vena contractan (nyquist n. 50-70cm/s; vuodon kapein kohta juuri aorttaläpän kammiopuolella)
- Ao (aortta kiinni; mittaus valvalvan sinuksen), LA (eteinen suurimmillaan), LVOT Diam (aortta auki)
- Ejektiofraktio ja seinämät
 - o M-moodi ja/tai B-kuvasta suoraan
 - IVSd, LVIDd, LWPWd, LVIDs

PSAX:

- Kammiotasolta supistuminen; onko hypokineettisiä alueita?
- Mitraaliläppätasolta
 - o Mahdollisen vuodon sijainti? Stenoosia (voi planimetroida)? Endokardiittiin viittaavia vegetaatioita?
- Aorttaläppätasolta
 - o Onko aorttaläppä kolmikuspinen? Visuaalisesti kalkkisuus? Avautuminen (voi planimetroida)? Mahdollisen vuodon sijainti?
 - o Eteisväliseinä (dopplerilla onko ASD:hen sopivaa virtausta eteisten välillä)
 - o Trikuspidaaliläppä; vuoto ja sen gradientti
 - o Pulmonaaliläpänkin päällä voi käydä dopplerilla

A4C:

- Nopea silmämääräinen arvio
 - o Ejektiofraktio?
 - o Paikalliset hypokineettiset alueet?
 - o Perikardiumeffuusiota?
 - o Läpät (kalkkisuus, liike, dopplerilla vuodot/stenoottismaiset virtaukset)
- Ejektiofraktio
 - o Simpsonin metodilla ensin piirtämällä EDV ja sitten ESV
- Diastoliikka
 - o PW mitraaliläpän avautumiskohdan kammiopuolelle -> E, A (ja näistä E/A)
 - o TDI mitraaliläpän lateraaliannulukseen kudokseen -> Lat E' (ja tästä E/Lat E')
- Mitraaliläppä
 - o Vuotoa? Stenoosia?
 - Vuodon gradeeraus EROA:lla
 - Vuodon kaula (aliasing 50-70 cm/s)+ PISA radius (aliasing velocity (Nyquist) vuodon suuntaan 30-40 cm/s (yleensä siis negatiivinen virtaus eli esim. -38.5 cm/s) + MR peak velocity (voi myös ottaa MR VTI, niin saa vuodon tilavuuden)
 - Stenoosin gradeerauksessa PW- ja CW-aallot molemmat
 - PW:llä peak velocity ja mean pressure gradient (piirretään E- ja A-aaltojen kompleksiksi)
 - CW:llä PHT (E-aallon deceleration slope)
- Oikea puoli sydäimestä
 - o Oikean kammion pitkittäissupistuvuus (TAPSE, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion); M-moodilla lateraaliannuluksen vertikaaliliike
 - o RVD1:n (oikean kammion läpimitta juuri trikuspidaaliläppärenkaan distaalipuolelta) voi joskus ottaa

A5C:

- Aorttaläppä
 - o Visuaalisesti kalkkisuus ja avautumisliike? Vuotoa? Stenoosia?
 - o Stenoosin laskeminen jatkuvuusyhtälöllä
 - LVOT Diam jo otettu PSLAX-ikkunasta; lisäksi tarvitaan LVOT VTI (PW ulosvirtauskanavasta) ja AV VTI (CW aortan läpi) -> kone laskee AVA
 - o Vuodon gradeeraus
 - Jetin leveys suhteessa LVOT:n leveyteen (silämääräinen)
 - CW:llä dopplersignaalin tiheys (silämääräinen) ja PHT
 - Vena contracta (nyquist n. 50-70cm/s; vuodon kapein kohta juuri aorttaläpän kammiopuolella); PISAssa taas nyquist 30-40 cm/s
 - Suprasternaalisesta ikkunasta voi arvioida flow reversalia (jos holodiastolinen, niin vuoto vakava)

Subxiphoidaalisesti / Subkostaalisesti:

- IVC (paksuus ja liike hengityksen mukana / sniffatessa)
 - Tarvittaessa myös täältä sydämen arviointi, jos muualta ei hyvää näkyvyyttä; yleensä myös paras paikka arvioida perikardiumnesteen määrää (vaipan paksuus mitataan diastoleessa)
-

Onko arvioitu?

- Yleisesti sydämen rakenne (onko mitään visuaalisesti poikkeavaa rakennetta havaittavissa; esim. trombit, hypertrabekulaatio, vegetaatiot yms) ja suhteet (esim. onko LV > RV)
- Pumppaustoiminta, dyssynkronia ja paikalliset liikehäiriöt
- Läpät ja niiden vuodot/stenoosit visuaalisesti
 - o Gradeeraus jos vaikuttavat merkittävältä
- Vasemman kammion mitat ja ejektiofraktio
- Aortan tyvi, vasen eteinen, LVOT Diam
- Aorttaläppä kaksi- vai kolmikuspinen?
- Trikuspidaaligradienetti
- TAPSE
- Diastoliikka (E, A ja E/Lat E')
- LVOT VTI ja AV VTI -> SV ja AVA (LVOT Diam myös tarvitaan)
- IVC
- Perikardiumtila
- Pleurasopet ja B-viivat